Tiroides y paratiroides

SEMIOLOGIA · Clase 41 · bocio, hipertiroidismo, hipotiroidismo y el calcio de las paratiroides

1 · LA TIROIDES Y EL BOCIO: LO QUE COMPRIME Y LO QUE SE OYE

Glándula tiroides
la única endocrina que se ve, palpa y ausculta; rodea la tráquea, con el esófago y el nervio recurrente detrás

Quién consulta
mujeres mayores de 40 años de zonas pobres en yodo; fármacos con yodo, amiodarona o litio

predispone al

si aumenta de volumen es un

se irriga por la

Irrigación F5
tiroidea superior de la carótida externa; tiroidea inferior de la arteria subclavia (tronco tirocervical)

Bocio
todo aumento de volumen de la tiroides, difuso o nodular

se evalúa con el

al crecer produce

Compresión
la glándula crecida aprieta las estructuras vecinas del cuello

si aprieta la tráquea:

si aprieta el recurrente:

si aprieta el esófago:

Disnea
por compresión de la tráquea

Disfonía o ronquera
por compresión del nervio recurrente

Disfagia
por compresión del esófago

obliga a explorar con el

obliga a explorar con el

obliga a explorar con el

si hay más flujo, se oye un

Examen directo del cuello
inspección, palpación (De Quervain o Lahey) y auscultación

al auscultar puede hallar un

sin soplo es compatible con

Soplo sobre el bocio
el flujo turbulento de una glándula hiperirrigada

Bocio no tóxico (pubertad, embarazo, falta de yodo): cambia el tamaño, no la función

orienta a

Bocio tóxico con hipertiroidismo, típico del Basedow-Graves

tiene detrás las

2 · EXCESO DE HORMONA: TODO SE ACELERA

si sobra hormona:

Exceso de hormona tiroidea F1
sube el metabolismo basal y acelera todos los sistemas

acelera todo:

sube el gasto:

modifica la

en el ojo produce

si se descontrola, llega a la

Desencadenantes F2
infecciones, traumas y estrés

agravan y precipitan la

Todo acelerado F4
calor y sudor, adelgazamiento con apetito, diarrea y nerviosismo con temblor fino e hiperreflexia

Gasto cardíaco aumentado F1
nunca disminuido: ruidos hiperfonéticos y presión diferencial aumentada

Piel y faneras F1
piel fina, caliente y húmeda; cabello fino; dolicolisis ungueal (uña de Plummer)

Exoftalmos
con bocio y ansiedad forma la facies basedowiana

Crisis hipertiroidea F2
agrava el cuadro; hipertermia sin infección, agitación, delirio y coma

por el hipermetabolismo da

orienta al

acelera el corazón:

orienta al

orienta al

Taquicardia sinusal
100 a 160 lat/min; fibrilación auricular como arritmia principal

Extremidades calientes y húmedas: las frías y secas no son de la crisis F2

orienta al

si se sostiene, lleva a

Insuficiencia cardíaca de gasto alto en los casos graves

Todo rápido y caliente confirma el **hipertiroidismo** antes del laboratorio

si falta hormona:

produce el

3 · DÉFICIT DE HORMONA: TODO SE ENLENTECE

Déficit de hormona tiroidea F3 · F4
metabolismo enlentecido; subclínico, clínico y coma mixedematoso

Precipitantes
frío invernal, infecciones, cirugías, traumas y depresores del SNC

en el extremo, lleva al

precipitan el

Coma mixedematoso: el extremo de la hipofunción

reduce la

enlentece todo:

seca la

baja la frecuencia:

Todo lento F3 · F4
debilidad y cansancio, intolerancia al frío, aumento de peso, estreñimiento, calambres y dolores musculares

Filtración glomerular disminuida
el riñón retiene agua

Corazón lento F3
bradicardia, pulso pequeño, QRS de bajo voltaje y derrame pericárdico

Piel y faneras F3
piel seca y descamativa sin sudor, uñas con surcos y caída del cabello

orienta al

retiene agua y produce

orienta al

orienta al

orienta al

si avanza, forma la

no se confunde con las

Trampas del banco F3 · F4
nerviosismo y pérdida de peso sin edema son del hiper: medir catecolaminas es del feocromocitoma (lámina 42)

Edema de piernas y periorbitario, con aumento de peso F3

orienta al

el periorbitario integra la

Todo lento y frío confirma el **hipotiroidismo clínico**

Facies mixedematosa
apática, bolsas subpalpebrales, enoftalmos y macroglosia

corresponde al

Corresponde al **hipotiroidismo avanzado** (la errata de 2020 dice «hiper»)

4 · PARATIROIDES QUE FALTAN: CALCIO BAJO Y TETANIA

Cuatro paratiroides
detrás de la tiroides; la PTH sube el calcio de la sangre

si sobran, causan

si faltan o se pierden, causan

Causas del hipoparatiroidismo F6
primario: posquirúrgico (el más frecuente), autoinmune, DiGeorge, infiltrativo, radiación; secundario: falta de magnesio

baja el calcio:

Calcio sérico bajo F7
menos de 8 mg/dL (normal 9-11), fósforo alto y PTH baja; magnesio, vitamina D y ECG con QT largo

hiperexcita el nervio:

Hiperexcitabilidad del nervio
el calcio bajo (o una alcalosis) la provoca

se busca con los

Signos de tetania
Trousseau: manguito sobre la sistólica unos 10 minutos, mano de partero; Chvostek: golpe delante de la oreja

si son positivos, hay

Tetania latente o franca: hay que pensar en las paratiroides tras una tiroidectomía

5 · PARATIROIDES QUE SOBRAN: CALCIO ALTO

Causas del hiperparatiroidismo F8
primario: adenoma único (el más frecuente), hiperplasia, carcinoma; secundario: renal crónica; terciario: autónoma

por el exceso de PTH,

PTH de más
saca calcio del hueso y lo manda a la sangre y al riñón

forma

desmineraliza el

Hueso desmineralizado
osteoporosis y dolor óseo

Cálculos renales
el calcio alto también estriñe (09a)

produce

producen

Calcio alto: hueso débil, cálculos y estreñimiento; lo contrario de la tetania

concepto · causa · mecanismo · signo · síntoma · técnica · desenlace · complicación · ejemplo · diagnóstico · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Tu teoría — 13a Semiología de la glándula tiroides, 06c Cuello, 05b (tetania y Trousseau), 06b (Chvostek); arterias tiroideas: anatomía; paratiroides: literatura